PROTOCOLLO 72

Mobilizzazione occipito-atlantoidea (Co-C1)

Migliorare la mobilità della giunzione cranio-cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Rigidità cervicale alta
- ✓ Postura con capo in avanti
- ✓ Cefalea occipitale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Presa

Mani sotto l'occipite, dita sulle masse laterali di C1.

2



FASE 2

Trazione

Leggera trazione craniale.

3



FASE 3

Movimento

Piccoli movimenti di flessione dell'occipite su C1.

4



FASE 4

Rivaluta

Controlla mobilità e sintomi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Screening vascolare preliminare
- ✓ Movimenti piccoli e controllati
- ✓ Comunicazione costante

Errori da evitare

- ! Rotazioni ampie
- ! Forza eccessiva
- ! Ignorare vertigini o nausea

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Retrazione del mento	Scivolare il mento indietro mantenendo lo sguardo orizzontale	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La mobilità cranio-cervicale influenza la posizione di riposo della mandibola.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.